

Presentación clínica y diagnóstico

1. Introducción y relevancia clínica

La **catarata** es la **pérdida progresiva de transparencia del cristalino**, lo que provoca una disminución gradual de la agudeza visual. Representa la **principal causa de discapacidad visual y ceguera reversible** a nivel mundial y en Chile.

El diagnóstico oportuno de catarata es esencial, dado que su tratamiento —la **cirugía con implante de lente intraocular (LIO)**— ofrece una **recuperación visual completa en la mayoría de los casos**.

En atención primaria, el médico general debe ser capaz de **reconocer la presentación clínica, realizar la evaluación inicial y derivar adecuadamente** a oftalmología.

En el contexto del **EUNACOM**, este tema se evalúa con frecuencia para determinar la capacidad del postulante de **diferenciar la catarata de otras causas de pérdida visual progresiva**, como glaucoma o degeneración macular, y para **identificar indicaciones quirúrgicas**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **cristalino** es una estructura biconvexa y avascular, formada por una cápsula elástica, fibras proteicas (cristalinas α , β y γ) y un epitelio subcapsular anterior.

Su transparencia depende del **orden estructural de las fibras**, la **ausencia de pigmentos y vasos**, y la **homeostasis osmótica** mantenida por la **bomba Na^+/K^+ ATPasa**.

Con la edad y factores ambientales, se produce:

- **Oxidación y agregación de proteínas.**
- **Disminución de glutatión y enzimas antioxidantes.**
- **Alteración de la permeabilidad de la cápsula.**
- **Acumulación de pigmentos (urocromo, lipofuscina).**

Estas alteraciones generan **dispersión de la luz (efecto Tyndall)**, lo que reduce la calidad óptica y genera los síntomas característicos.

Clasificación anatómica (relevante para diagnóstico clínico)

Tipo	Localización de la opacidad	Manifestaciones típicas
Nuclear	Núcleo del cristalino	Disminución progresiva de visión lejana, miopización, colores amarillentos.
Cortical	Corteza periférica	Halos, deslumbramiento, visión variable según iluminación.
Subcapsular posterior	Justo bajo la cápsula posterior	Disminución de visión cercana, rápida progresión, afecta lectura.
Mixta	Combinación de las anteriores	Presentación avanzada.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas

Los síntomas dependen de la localización y densidad de la opacidad, pero el cuadro clásico incluye:

Síntoma	Descripción
Disminución progresiva de la agudeza visual	Sin dolor ni enrojecimiento. Empeora gradualmente, bilateral (aunque asimétrica).
Deslumbramiento / halos luminosos	Especialmente al conducir de noche; típico de catarata cortical o subcapsular.

Pérdida de contraste y nitidez	“Ve bien con buena luz, mal en penumbra.”
Alteración en la percepción de colores	Tonalidad amarillenta o marrón de los objetos.
Cambio frecuente de anteojos	Fenómeno de “miopía adquirida” en catarata nuclear.
Diplopía monocular	En catarata cortical incipiente.

□ *Regla práctica:* Si la pérdida visual es **gradual, indolora y bilateral**, con **reflejo pupilar conservado**, siempre considerar **catarata**.

3.2 Signos al examen físico

1. Inspección general:

- Pupila con reflejo blanquecino o grisáceo (en catarata madura).
- En estadios iniciales, el ojo se ve normal externamente.

2. Reflejo rojo (test de Bruckner):

- Disminuido o ausente.
- Asimetría sugiere opacidad unilateral o densa.

3. Biomicroscopía (lámpara de hendidura):

- Visualiza el tipo y densidad de la opacidad.
- En catarata nuclear → color amarillento-marrón (“brunesciente”).
- En catarata cortical → opacidades radiales o sectoriales.
- En subcapsular → velo granular posterior.

4. Oftalmoscopía directa:

- Difícil en cataratas densas (no se ve fondo de ojo).

Agudeza visual (test de Snellen)	Cuantificar pérdida visual.	< 20/40 (0,5) justifica derivación.
Reflejo rojo (oftalmoscopio directo)	Detectar opacidad del cristalino.	Disminuido o ausente = sospecha.
Lámpara de hendidura	Evaluar localización y tipo de opacidad.	Diagnóstico confirmatorio.
Oftalmoscopia directa o indirecta	Valorar retina si transparencia lo permite.	En catarata densa puede ser imposible.

4.2 Estudios preoperatorios (evaluación oftalmológica completa)

Examen	Finalidad	Observaciones
Tonometría (Goldmann o aplanación)	Descartar glaucoma asociado.	Es mandatorio en toda evaluación.
Ecografía ocular (modo B)	Evaluar retina y vítreo si no se ve fondo.	Identifica desprendimiento de retina, tumores o hemorragia vítrea.
Biometría óptica / ultrasónica	Calcular poder del lente intraocular (LIO).	Fundamental antes de cirugía.
Paquimetría y queratometría	Medir grosor corneal y curvatura.	Mejora precisión refractiva postoperatoria.
Topografía corneal (si disponible)	Evaluar irregularidades corneales.	Útil en cirugía refractiva o astigmatismo.

4.3 Criterios diagnósticos (MINSAL / SOCHIOF)

Diagnóstico de **catarata clínicamente significativa** cuando cumple:

1. Presencia de **opacidad del cristalino** visible a biomicroscopía, y
2. Disminución de **agudeza visual corregida $\leq 20/60$ (0,3)**, y
3. Impacto funcional documentado (dificultad para actividades cotidianas).

Si además el paciente cumple criterios de **discapacidad visual bilateral**, califica para tratamiento **GES de catarata**.

5. Tratamiento inicial y criterios de derivación

Aunque el tratamiento definitivo es quirúrgico, la evaluación inicial y la derivación oportuna son competencias del médico general.

5.1 Conducta en Atención Primaria (APS)

Derivar a oftalmología si se cumple cualquiera de los siguientes:

- Agudeza visual corregida $\leq 20/60$ (0,3).
- Disminución visual progresiva que afecta la funcionalidad.
- Reflejo rojo disminuido o ausente bilateralmente.
- Sospecha de catarata congénita o traumática.
- Comorbilidad que requiere evaluación especializada (diabetes, corticoides crónicos, trauma ocular).

Mientras espera derivación:

- Reforzar uso de lentes y buena iluminación.
 - Control metabólico (DM, HTA).
 - Evitar corticoides innecesarios.
-

5.2 Evaluación preoperatoria (oftalmología especializada)

Incluye:

1. **Confirmación diagnóstica con biomicroscopía.**
2. **Determinación del tipo y severidad** (clasificación LOCS III o Slit-Lamp Grading).
3. **Cálculo del LIO mediante biometría.**
4. **Exclusión de patología ocular asociada** (glaucoma, retinopatía, DMAE).

6. Complicaciones y pronóstico

Aunque el diagnóstico en sí no tiene complicaciones, el **retraso en la detección y derivación** puede llevar a:

Complicación	Descripción	Consecuencia
Catarata hipermadura (morgagniana)	Licuefacción cortical, luxación nuclear.	Aumento riesgo quirúrgico y glaucoma facomórfico.
Glaucoma facolítico	Fugas de proteínas del cristalino → inflamación y bloqueo trabecular.	Dolor ocular agudo, pérdida visual.
Ambliopía irreversible (niños)	Falta de estimulación visual en catarata congénita.	Pérdida visual permanente.

Pronóstico visual:

Excelente si se realiza cirugía antes de complicaciones; >95% de los pacientes recupera visión funcional.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. La **catarata** se presenta como **pérdida visual bilateral, indolora y progresiva**.
 2. El **reflejo rojo ausente o disminuido** orienta fuertemente al diagnóstico.
 3. La **subcapsular posterior** causa peor visión cercana y deslumbramiento.
 4. En **trauma contuso**, sospechar **catarata en roseta**.
 5. Todo **recién nacido con reflejo rojo anormal** debe ser derivado urgente.
 6. **No existen tratamientos farmacológicos efectivos**.
 7. **Catarata + PIO elevada** → sospechar **glaucoma facomórfico**.
-

Errores comunes

- No evaluar agudeza visual en ambos ojos por separado.
 - Confundir catarata con opacidades corneales o DMAE.
 - No derivar a oftalmología cuando hay impacto funcional.
 - Omitir tonometría antes de cirugía (riesgo de glaucoma oculto).
 - No realizar evaluación de reflejo rojo en lactantes.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La catarata produce **pérdida visual progresiva, bilateral e indolora**, con **reflejo rojo disminuido**.
2. Su diagnóstico es **clínico**, basado en **biomicroscopía** y **evaluación funcional visual**.
3. Los síntomas más comunes son **disminución visual, deslumbramiento y cambios refractivos**.

4. No existen tratamientos médicos efectivos; la **cirugía con LIO** es el único manejo curativo.
5. El médico general debe **derivar a oftalmología** ante pérdida visual significativa o reflejo rojo anómalo.
6. En el recién nacido, una catarata no tratada provoca **ambliopía irreversible**.
7. La **detección y derivación temprana** mejoran el pronóstico visual y funcional.